

AV2 PEDRO -

Resumo para Estudo – Articulação Sacroilíaca (ASI)

A articulação sacroilíaca (ASI) é formada pela união entre o sacro e os ossos ilíacos da pelve. Sua principal função é transmitir cargas entre o tronco e os membros inferiores, além de absorver impactos durante atividades como caminhar, correr e saltar. É uma articulação semimóvel (anfiartrose) e depende principalmente da estabilidade ligamentar para seu funcionamento.

Anatomia da Pelve

Ossos envolvidos

- Sacro
- Cóccix
- Osso Inominado:
 - Ílio
 - Ísquio
 - Púbis
- Fêmur

Articulações relacionadas

- Lombossacral
- Sacrococcígea
- Sacroilíaca

Principais músculos

- Glúteo Máximo
- Glúteo Médio
- Glúteo Mínimo
- Adutor Magno
- Piriforme
- Quadrado Femoral
- Gêmeo Superior
- Obturatório Interno
- Obturatório Externo

Disfunção Sacroilíaca

Ocorre quando há perda da função normal da articulação devido a alterações biomecânicas, como:

- Hipomobilidade
- Fixação articular
- Subluxação
- Mau alinhamento

A ASI pode ser uma importante fonte de dor lombar e pélvica.

Disfunções mais comuns

- Bursite trocantérica
- Hipomobilidade
- Fissuras
- Tendinopatias dos glúteos
- Síndrome do piriforme

Sinais e Sintomas

Pacientes com disfunção sacroilíaca podem apresentar:

- Dor ao andar
- Dor ao sentar e levantar
- Dor ao subir ou descer escadas
- Dor ao entrar ou sair do carro
- Dor lombar na região L5-S1
- Dor pélvica
- Dor nas nádegas
- Ciatalgia
- Dor na articulação sacroilíaca
- Dor fêmoro-acetabular

Testes Específicos da Articulação Sacroilíaca

1. Teste de Impulso Sacral (Sacral Thrust)

Objetivo: provocar dor na ASI.

Execução:

- Paciente em decúbito ventral.
- Examinador aplica pressão anterior sobre o sacro.

Positivo quando:

- Reproduz a dor na região sacroilíaca.

2. Teste de Compressão Sacroilíaca

Objetivo:

- Reproduzir os sintomas do paciente.

Execução:

- Paciente em decúbito lateral.
- Compressão sobre a crista ilíaca.

Positivo quando:

- Há dor ou reprodução dos sintomas.

3. Teste de Distração Sacroilíaca

Objetivo:

- Avaliar os ligamentos sacroilíacos anteriores.

Execução:

- Paciente em decúbito dorsal.
- Pressão lateral e inferior nas EIAS.

Positivo quando:

- Surge dor unilateral em glúteo ou face posterior da perna.

Palpação de Pontos Gatilho Miofasciais

Glúteo Máximo

- Paciente em decúbito ventral.
- Coxa contralateral levemente flexionada para aumentar a tensão muscular.

Glúteo Médio

- Paciente deitado sobre o lado não afetado.
- Pequena flexão do quadril.
- Coxim entre os joelhos.

Glúteo Mínimo

Pontos anteriores:

- Decúbito dorsal.
- Membro em extensão.

Pontos posteriores:

- Decúbito lateral.

- Quadril abduzido e levemente flexionado.

Piriforme

- Paciente em decúbito ventral.
- Palpação profunda.

Tratamento Fisioterapêutico

Objetivos:

- Reduzir a dor.
- Recuperar mobilidade.
- Restaurar estabilidade.
- Corrigir desequilíbrios musculares.

Recursos utilizados

- Manipulação articular
- Mobilização articular
- Liberação de tecidos moles
- Tratamento de pontos gatilho miofasciais
- Exercícios cinesioterapêuticos específicos
- Fortalecimento muscular

Resumo de Prova (decorar)

- ✓ Função da ASI → absorção de impacto e transmissão de cargas.
- ✓ Principais disfunções → hipomobilidade, bursite trocantérica, tendinopatias glúteas e síndrome do piriforme.
- ✓ Sintomas clássicos → dor lombar, dor pélvica, dor glútea e ciatalgia.
- ✓ Testes importantes:
 - Sacral Thrust
 - Compressão Sacroilíaca
 - Distração Sacroilíaca
- ✓ Tratamento:
 - Manipulação articular
 - Mobilização
 - Liberação miofascial

- Exercícios de mobilidade e estabilidade
- Fortalecimento muscular.

Resumo – Dry Needling (Agluhamento a Seco)

O **Dry Needling** é uma técnica fisioterapêutica que utiliza agulhas filiformes sólidas sem aplicação de medicamentos. Seu principal objetivo é tratar dores miofasciais e disfunções musculoesqueléticas, promovendo alívio da dor, regeneração e recuperação dos tecidos.

Dry Needling x Acupuntura

- Ambos utilizam agulhas.
- A **acupuntura** baseia-se no equilíbrio energético.
- O **Dry Needling** baseia-se na neurofisiologia musculoesquelética e atua diretamente nos **Trigger Points (Pontos Gatilho)**.

Síndrome Dolorosa Miofascial

É uma condição caracterizada por bandas musculares tensas e palpáveis contendo pontos sensíveis que podem gerar dor local ou dor referida (em outra região do corpo). Pode acometer músculos, fáscias e tecidos conjuntivos.

Trigger Points (Pontos Gatilho)

- Pequenos nódulos (0,25 a 1 cm).
- Localizados em músculos e fáscias.
- Comuns em regiões de alta demanda postural.
- Surgem por sobrecarga, fadiga, traumas, estresse físico ou emocional e disfunções articulares.

Identificação dos Trigger Points

- **Sinal do pulo:** reação dolorosa ao pressionar o ponto.
- **Banda tensa palpável:** semelhante a uma corda.
- **Dor referida:** dor sentida distante do ponto gatilho.
- Pode ser auxiliada por ultrassonografia.

Características Clínicas

- Dor muscular difusa.
- Sensação de peso, queimação ou latejamento.
- Dor irradiada.
- Presença de banda muscular tensa palpável.

Tipos de Dry Needling

- **Superficial:** utilizado em regiões mais sensíveis, como tórax e crânio.
- **Profundo:** busca provocar a **LTR (Local Twitch Response)**, uma contração involuntária da banda muscular que leva ao relaxamento do músculo.

Formas de Inserção da Agulha

- Perpendicular: **90°**
- Oblíqua: **45°**
- Horizontal: **15°–20°**

Manipulação da Agulha

- Inserção rápida com mandril.
- Avanço lento após a inserção.
- Pode haver pistonamento (movimento de vai e vem).
- Rotação horária ou anti-horária para estimular a fáscia.
- Tempo médio mais utilizado: cerca de **8 minutos** (literatura varia de 3 a 30 minutos).

Red Flags (Atenção)

Investigar melhor casos com:

- Menores de 20 anos ou maiores de 55 anos.
- Dor em repouso.
- Febre e perda de peso sem explicação.
- Dor torácica.
- Alterações urinárias.
- Uso prolongado de corticoides.
- Sintomas sistêmicos.

Biossegurança

- Lavar as mãos.
- Usar luvas.
- Higienizar a pele com álcool 70%.
- Descartar agulhas corretamente.
- Utilizar agulhas descartáveis.

Possíveis Respostas ao Agulhamento

- Dor surda.
- Dormência.
- Formigamento.
- Distensão.

- Sensação de calor ou frio.
- Espalhamento da sensação.

Cuidados e Riscos

Áreas proibidas:

- Mamilos.
- Umbigo.
- Órgãos genitais externos.

Áreas de alto risco:

- Próximas a estruturas vitais.
- Região torácica (risco de pneumotórax).
- Pacientes psicologicamente instáveis.

Intercorrências

- Sangramento → compressão local.
- Agulhamento de nervo → retirar a agulha e tranquilizar o paciente.
- Agulha presa → massagear a região.
- Agulha quebrada → remover com pinça.
- Desmaio → retirar todas as agulhas, deitar o paciente, elevar as pernas e oferecer água.

Resumo para Prova

- ✓ Dry Needling = agulhamento sem medicamento.
- ✓ Atua em Trigger Points.
- ✓ Indicado para dor miofascial e musculoesquelética.
- ✓ Identificação: sinal do pulso, banda tensa e dor referida.
- ✓ Tipos: superficial e profundo.
- ✓ LTR = contração involuntária que relaxa a banda muscular.
- ✓ Angulações: 90°, 45° e 15–20°.
- ✓ Red Flags: dor em repouso, febre, perda de peso, dor torácica e sintomas sistêmicos.
- ✓ Biossegurança obrigatória.
- ✓ Principal risco: pneumotórax em regiões torácicas.

Resumo – Fisiopatologia e Técnicas Manuais nas Lesões da Coluna Vertebral

A **coluna vertebral** é formada por vértebras e discos intervertebrais, sustentando cerca de **2/5 do peso corporal**. Possui curvaturas fisiológicas e é dividida em regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. Seus músculos garantem movimentos, postura e estabilidade.

Funções da Coluna

- Sustentar o corpo.
- Permitir movimentos (flexão, extensão, rotação e inclinação lateral).
- Proteger a medula espinhal.
- Manter a postura e o equilíbrio.

Principais Músculos Envolvidos

Cervical

- Trapézio superior
- Elevador da escápula
- ECOM (esternocleidomastoideo)
- Escalenos
- Suboccipitais

Lombar

- Quadrado lombar
- Psoas
- Glúteo médio e mínimo
- Piriforme

Disfunções Mais Comuns

- Hérnia de disco
- Osteófitos (bicos de papagaio)
- Artrose da coluna
- Espondilite anquilosante
- Síndrome da cauda equina
- Estenose lombar
- Fraturas vertebrais
- Síndrome miofascial
- Alterações posturais

Hérnia de Disco

Ocorre quando o **núcleo pulposo** se desloca através do anel fibroso. Com o envelhecimento, o disco perde água e resistência, facilitando lesões.

Classificação

1. **Abaulamento** – início da deformação.
2. **Protrusão** – núcleo avança até os últimos anéis.
3. **Extrusão** – rompimento completo dos anéis.
4. **Sequestro** – fragmento do núcleo se desprende.

Síndrome da Cauda Equina

Compressão grave dos nervos na porção inferior da coluna, podendo causar:

- Retenção urinária.
- Incontinência urinária e fecal.
- Perda de reflexos.
- Disfunção sexual.
- Dificuldade para caminhar.
- Possível paralisia.

Principais Sinais e Sintomas

- Dor ao sentar, levantar ou caminhar.
- Dor ao subir escadas.
- Dor lombar crônica.
- Formigamento e dormência nos membros.
- Fraqueza muscular.
- Dor irradiada para braços ou pernas.
- Dificuldade para urinar ou evacuar.
- Anestesia perineal.

Principais Causas

- Levantar peso excessivo.
- Movimentos repetitivos.
- Inclinar e girar o tronco frequentemente.
- Sedentarismo.
- Esportes de impacto.
- Vibração constante no trabalho.
- Má postura prolongada.

Avaliação Fisioterapêutica

1. Anamnese.

2. Triagem de Red Flags.
3. Avaliação postural.
4. Exame físico.
5. Testes clínicos.
6. Exames complementares.

Dor Muscular (Pontos Gatilho)

Cervical

- Trapézio superior
- Elevador da escápula
- ECOM
- Escalenos
- Suboccipitais

Lombar

- Quadrado lombar → dor em glúteos e coxa.
- Psoas → dor lombar e na coxa.
- Glúteo médio/mínimo → dor semelhante à ciática.
- Piriforme → dor irradiada pela coxa.

Resumo para Prova

- ✓ Coluna = sustentação + movimento + proteção da medula.
- ✓ Hérnia: abaulamento → protrusão → extrusão → sequestro.
- ✓ Síndrome da cauda equina = emergência neurológica.
- ✓ Principais sintomas: dor, dormência, formigamento e fraqueza.
- ✓ Principais causas: peso excessivo, sedentarismo e má postura.
- ✓ Avaliação: anamnese + exame físico + testes clínicos.
- ✓ Pontos gatilho cervicais e lombares são causas frequentes de dor referida.